健康 · 06 · 脑与认知

老年痴呆，是不是人老了都这样？

为什么越来越多、怎样早发现、哪些能预防、新药和照护

约 2.6 万字 · 细读约 55 分钟 · 34 章 · 35 条资料出处

家里的老人同一件事问好几遍、炒菜忘了关火、在走了几十年的路上迷路，是不是“人老了都这样”？老年痴呆为什么好像越来越多？有没有办法预防？银杏和各种“补脑”产品有没有用？这几年的新药到底有多大用？家里有人得了病，怎样照顾，照顾的人又怎样撑下去？这一篇从大脑里发生了什么讲起，按证据的分量一项一项看，最后落到照护、信仰和每个年纪能做的事。

先说结论

越来越多，是真的

中国 60 岁以上的人约 6% 有痴呆、约 15.5% 有轻度认知障碍；老人越来越多，病人也就越来越多

2015—2018 全国调查

同龄人的风险在降

欧美的长期研究里，同样年纪的人得痴呆的比例每十年少了约 13%：老了不等于一定会得

可以改变的有一大半

十四个可以改变的因素，加起来约占痴呆的 45%；听力、坏胆固醇、教育、孤独排在前面

柳叶刀委员会 2024

证据最硬的是降血压

中国农村 3.4 万人的试验：村医帮着把血压降下来，四年里痴呆少了约 15%

随机试验

补脑产品多数没证据

银杏在 3 千多名老人身上用了六年，没有减少痴呆；“补脑”保健品不能代替看病

新药有用，但不大

两种新抗体药让早期病人恶化得慢了约四分之一，要定期查磁共振防脑水肿；照护和陪伴一样重要

下面先讲大脑里发生了什么、怎样早一点发现，再按证据的分量讲预防，然后讲补充剂、药物和照护。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

第一部分 · 先把问题摆上桌

01 “妈，你刚才问过了”

02 真的越来越多了吗?

03 “痴呆”这个名字

第二部分 · 脑子里发生了什么

04 正常的健忘、轻度认知障碍、痴呆

05 几种常见的痴呆

06 阿尔茨海默病：在症状出现以前很多年就开始了

07 血管性痴呆：脑子的“水管”出了问题
08 为什么老了容易得
第三部分 · 早一点发现
09 哪些信号要留意
10 先排除能治好的原因
11 去哪里查、查什么
12 查出来了，要不要告诉他?
第四部分 · 能预防吗：按证据的分量排
13 近一半，可能可以推迟或预防
14 降血压：证据最硬的一件事
15 耳朵和大脑：听力为什么排第一
16 眼睛：白内障和大脑
17 多管齐下：芬兰和美国的两项试验
18 动起来，睡够觉
19 用脑，和人来往
20 小心几类常用的药
21 还有哪些说法：疫苗、减肥针、喝酒、头部外伤
第五部分 · 吃什么、补什么
22 吃什么：一项让人意外的试验
23 银杏、鱼油和“补脑”产品
24 中医中药
第六部分 · 药物：老药、新药和争议
25 改善症状的老药
26 新药：清除淀粉样蛋白的抗体
27 “九期一”的来龙去脉
第七部分 · 照护：病人、家人和教会
28 日常相处：几句话、几件事
29 脾气变了、晚上闹，怎么办
30 照顾的人，也需要被照顾
31 当他忘了自己，上帝也不忘记他
第八部分 · 一生的功课与结语
32 每个年纪能做的事
33 常见问题

34 结语：不是“人老了都这样”

第一部分

先把问题摆上桌

01 “妈，你刚才问过了”

王阿姨七十四岁，退休前是小学老师，一辈子记性好，班上几十个学生的名字张口就来。

这两年，女儿发现她有点不对劲。同一件事，一个下午问三遍：“你明天几点上班？”刚说完，过一会儿又问。炒菜忘了关火，锅烧黑了两次。有一次去菜市场，走了二十年的路，她站在路口不知道往哪边拐。

女儿说：“妈，你刚才问过了。”王阿姨脸一沉：“我什么时候问过？”

家里人商量了几回，最后都说：“人老了，都这样。”

真的是“人老了都这样”吗？这一篇想回答大家常问的几个问题：

- 老年痴呆是不是真的越来越多了？为什么？
- 正常的健忘和痴呆，怎样分？什么时候该去看医生？
- 有没有办法预防？哪些办法有研究证据，哪些只是说法？
- 银杏、鱼油、各种“补脑”的保健品，到底有没有用？
- 这几年的新药是怎么回事？国产的“九期一”后来怎样了？
- 家里有人得了痴呆，怎样照顾，照顾的人自己怎样撑下去？

先说结论：**痴呆不是“人老了都这样”，它是一种病。**年纪是最大的风险，但不是命定；有一大半的风险来自可以改变的事情。早一点发现，有些原因还能治好；就算是治不好的那一类，早知道也能多做准备、少走弯路。

这一篇怎样读

- **担心家里老人的，**请先读第 4 章《正常的健忘、轻度认知障碍、痴呆》、第 9 章《哪些信号要留意》和第 10 章《先排除能治好的原因》：正常健忘和痴呆怎样分，哪些信号要留意，哪些原因能治好。
- **想预防的，**请读第四部分。那里按证据的分量排：有的有随机试验，有的只有观察研究，有的试验做了却没有效果。
- **正在照顾病人的，**请读第七部分：日常怎样相处、脾气变了怎么办、照顾的人自己怎样喘口气。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；任何用药、换药、停药，都要先问医生。

02 真的越来越多了吗?

先回答很多人心里的那句话：**“这个时代，老年痴呆似乎越来越常见了。”**

是的，病人确实越来越多。可是原因要分两层看，这两层的方向正好相反。

第一层：老人多了。痴呆主要是老年人的病，年纪越大越多。中国的老人这些年增加得很快。国家统计局的数据，2025 年末，全国 60 岁及以上的人有 3.23 亿，占总人口的 23.0%；65 岁及以上的有 2.24 亿，占 15.9%[1]。活到八九十岁的人多了，得痴呆的人数自然也就多了。

目前最新的全国数据，来自 2015 年 3 月到 2018 年 12 月的一次大调查。研究者在全国 12 个省市、96 个调查点，随机找了 46,011 名 60 岁以上的人，一个一个做神经心理测验，2020 年发表[2]：

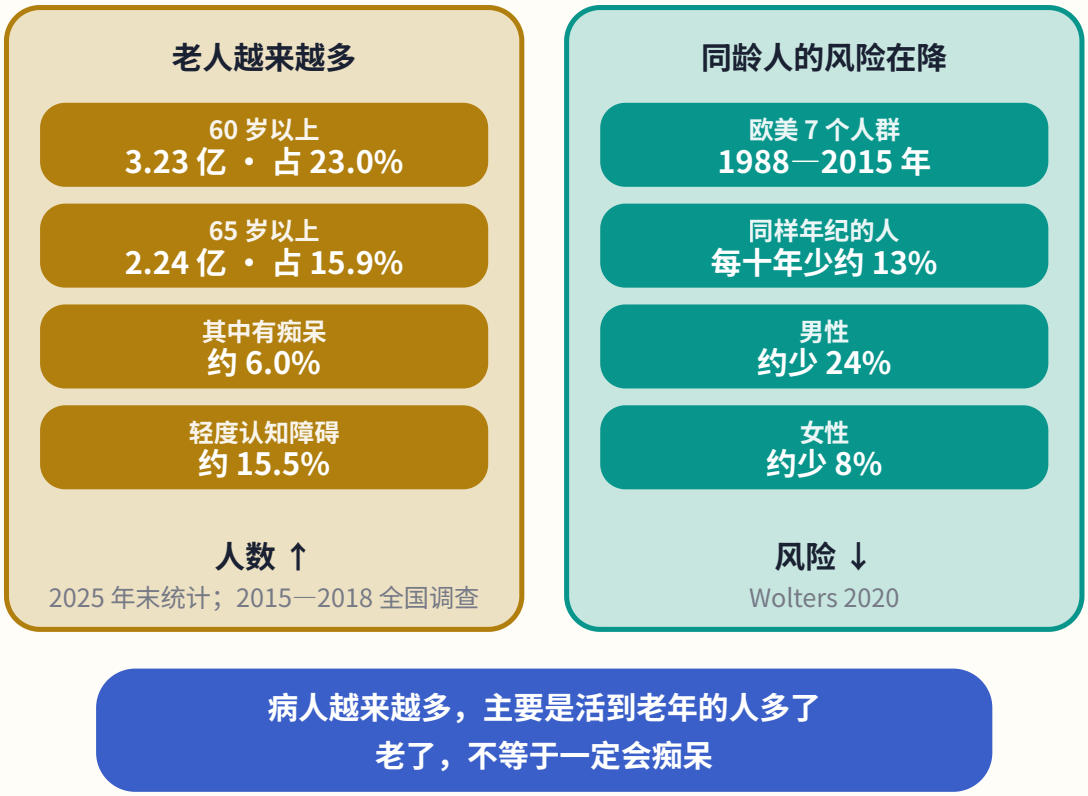
- **痴呆约 6.0%，**按当时的人口推算约 1,507 万人。其中阿尔茨海默病 3.9%（约 983 万），血管性痴呆 1.6%（约 392 万），其他类型 0.5%。
- **轻度认知障碍约 15.5%，**约 3,877 万人。这是介于正常和痴呆之间的阶段，第 4 章《正常的健忘、轻度认知障碍、痴呆》会细讲。

这是七八年前的调查。这几年老人又多了几千万，编者粗略地想：比例就算不变，人数也一定更多了。这只是推想，不是新的调查数字。

第二层：同样年纪的人，风险在降。这是很多人没想到的。欧洲和美国有 7 个人群研究，从 1988 年一直跟踪到 2015 年，一共 49,202 名 65 岁以上的人。研究者比较不同年代、同样年纪的人：**得痴呆的比例每十年少了约 13%**，男性降得更多（约 24%），女性约 8%[3]。

为什么会降？研究者自己也说要继续找原因。常被提到的有：受教育的人多了，血压、胆固醇控制得比以前好，吸烟的人少了。这一点第 13 章《近一半，可能可以推迟或预防》还会讲。

图 1　病人越来越多，同龄人的风险却在降：两层原因



编者根据国家统计局、Jia 2020、Wolters 2020 整理

把两层放在一起，就是这一章的答案：**病人越来越多，主要是因为活到老年的人越来越多；而对一个人来说，“老了就一定会痴呆”并不是真的。**同样活到八十岁，今天的人比三十年前的人，机会更好一些。这是好消息，也是一个提醒：有些事情，是可以改变的。

一 为什么中国没有这样的“趋势”数据？

要看“同龄人的风险有没有降”，需要用同样的方法，在同一群地方，连续几十年调查。欧美有几个这样的老队列，比如美国的弗明汉研究，从上世纪就开始了。中国的全国性痴呆调查做得比较晚，前后几次的方法和诊断标准也不完全一样，所以很难直接比。编者在 PubMed 上没有找到能回答“中国同龄老人的痴呆风险是升还是降”的可靠全国数据，这里就不下结论。

另外要知道：欧美的数据，大多来自白人为主的人群，研究者也提醒，不一定能直接套到其他人群身上[3]。

03 “痴呆”这个名字

说到这里，先说说名字。

“老年痴呆”是老百姓最熟悉的叫法。医学上的“痴呆”，说的不是一个人笨，也不是性格出了问题，而是**大脑因为疾病，记忆、思考、说话、判断这些能力越来越差，差到影响了日常生活。**它是一组症状的总称，背后可以是好几种不同的病。最常见的是阿尔茨海默病，其次是血管性痴呆。

这些年，很多医生和病人家属觉得“痴呆”两个字太刺耳，像是在骂人。有人改叫“认知症”“失智症”，台湾地区多用“失智症”，日本改叫“认知症”。叫法在变，但病是同一个病。

编者的理解：叫法不是小事。很多家庭迟迟不肯带老人去看病，就是怕“被说成痴呆”，怕丢面子。其实**得这个病不丢人，就像得了高血压、糖尿病不丢人一样。**病人还是那个人，是我们的父亲、母亲、弟兄、姊妹。本篇为了大家看得懂，仍然用“痴呆”这个词，但心里请记住：我们说的是一种病，不是在给人贴标签。

第二部分

脑子里发生了什么

04 正常的健忘、轻度认知障碍、痴呆

人人都会忘事。钥匙放哪儿了，一个熟人的名字到了嘴边说不出来，走进房间忘了要拿什么。这些是不是痴呆的开始？

多数不是。年纪大了，脑子反应会慢一点，一下子想不起来的事情多一点，这是正常的老化。关键在于：**正常的健忘，过后能想起来，提醒一下就记得；也不影响把日子过好。**

可以把记忆和思考的变化，想成一段往下走的台阶：

图 2 从正常老化到痴呆：一段往下走的台阶



编者整理的示意；判断要请医生做测验和检查

- **正常老化：**反应慢一点，偶尔想不起名字，但提醒一下就记得，自己的事情都能打理。
- **主观认知下降：**自己觉得记性不如从前，但测验的成绩还在正常范围。很多人停在这里，也有一部分人以后会往下走。

- **轻度认知障碍：**测验的成绩已经比同龄、同样文化程度的人差了，家里人也看得出来；可是买菜、做饭、管钱这些日常的事，大体还能自己做。中国 60 岁以上的人约 15.5% 在这一级[2]。这一级很要紧：有的人会慢慢发展成痴呆，有的人一直停在这里，也有的人找到原因、治好以后又回到正常。
- **痴呆：**能力差到影响日常生活了。会忘了刚发生的事、在熟悉的地方迷路、管不了钱、不会用以前会用的电器。再往下，从轻度到中度、重度，慢慢需要别人照顾吃饭、穿衣、洗澡。

常见的情形	正常的健忘	要留意的变化
想不起一件事	过一会儿自己想起来，或者提醒一下就记得	整件事都不记得发生过，提醒了也想不起来
重复问话	偶尔一次	同一件事一天问好几遍，自己不觉得问过
找东西	钥匙放错了地方，回头找得到	东西放在奇怪的地方（钱包放进冰箱），还怀疑别人偷了
认路	到陌生地方要问路	在走了多年的路上迷路
日常事务	做事慢一点，但能做完	做了几十年的菜不会做了，账算不清，家电不会用了
性格和情绪	有自己的脾气，但和以前差不多	变得多疑、易怒、退缩，像换了一个人

这张表是编者整理的，只是帮大家对照，不能用来自己下诊断。**真正要判断，得请医生做测验和检查。**

05 几种常见的痴呆

“痴呆”像一个大门，门后面有好几个房间。中国的全国调查里，痴呆病人大约三分之二是阿尔茨海默病，四分之一多是血管性痴呆，其余是别的类型[2]。

阿尔茨海默病	最常见。慢慢开始、慢慢加重，最早常常是记不住新近的事。下一章细讲。
血管性痴呆	脑子的血管出了问题：一次大的中风，或者许多次小的“腔隙性梗死”、长期高血压造成的小血管病。常常一阵一阵地往下掉，走路、反应慢比忘事更明显。
混合型	老年人里很常见：阿尔茨海默病的改变和血管的问题同时都有。
路易体痴呆	清醒程度忽好忽坏，常有很真切的幻觉（看见屋里有人、有小动物），常伴随手抖、动作慢，像帕金森病。
额颞叶痴呆	发病常常比较早（五六十岁），先是性格和行为变了：说话不顾场合、乱花钱、不讲卫生，记性反倒还可以。

为什么要分类型？因为**不同类型，用药和照顾的重点不一样。**比如路易体痴呆的病人，对某些安定类、抗精神病类的药特别敏感，用了反而可能更糟。所以诊断要交给医生，家里人不要自己找药给老人吃。

06 阿尔茨海默病：在症状出现以前很多年就开始了

1901 年，德国医生阿尔茨海默接诊了一位五十一岁的女病人。她记忆越来越差、多疑、迷失方向。1906 年她去世后，阿尔茨海默在显微镜下看她的大脑，看到两样不正常的东西，当年就作了报告。一百多年后，这两样东西仍然是这个病的标志：

- **斑块：**一种叫“β-淀粉样蛋白”的碎片，在神经细胞外面越积越多，粘成一团一团。
- **缠结：**神经细胞里面，一种叫“tau 蛋白”的东西变了形，缠成一团乱麻，细胞里运东西的“轨道”就塌了。

接着，神经细胞之间的连接越来越少，细胞一批一批地死掉，大脑慢慢萎缩。最早受累的，常常是管“记新事”的海马。所以很多病人以前的事记得清清楚楚，刚才吃没吃饭却说不上来。

图 3 阿尔茨海默病：脑子里的改变，比症状早很多年



编者整理的示意，不是真实数据

这里有一个重要的发现：**这些改变，常常在症状出现以前很多年、甚至十几二十年就开始了。**大脑的“储备”很大，前面坏了一部分，别的部分还能顶上，所以人看起来还好。等到家里人察觉，脑子里的改变往往已经走了很长一段路。

编者的理解：这件事有两个意思。第一，**预防要趁早，**中年时管好血压、听力、血糖，保护的是二十年后的大脑。第二，新的抗体药都只用在早期，第 26 章《新药：清除淀粉样蛋白的抗体》会讲为什么。

一 基因：家里有人得过，我是不是也会得？

中国的全国调查里，父母有痴呆的人，自己得痴呆的比例明显更高[2]。这既有基因的原因，也有一家人生活习惯相近的原因。

大多数阿尔茨海默病不是“一个坏基因”造成的，而是许多基因和生活一起作用。常被提到的是一种叫 APOE ε4 的基因型，带它的人风险高一些，但带它的人很多一辈子没有得病，不带的人也会得。极少数家庭有很强的遗传（常常四五十岁就发病，一家几代都有），那是另一回事，要找专科医生。

编者的理解：基因像是手里拿到的牌，生活是怎样打这副牌。家族史不是判决书，反而是提醒我们更早开始保护大脑的理由。

07 血管性痴呆：脑子的“水管”出了问题

大脑只占体重的五十分之一左右，却要用掉全身约五分之一的血。它一刻也离不开血液送来的氧气和糖。

血管性痴呆，就是给大脑送血的“水管”出了问题。有时是一次大中风，一大片脑组织坏了；更常见的是悄悄的：长期血压高，把脑子深处细小的血管磨得又厚又硬，一点一点地堵，一处一处地小梗死。每一次都不大，人也许没有感觉，可加在一起，管思考、管走路的线路就断了不少。

这一类病人，常常先是**反应慢、做事没条理、走路拖步**，然后才是忘事。也常常像下台阶一样，一阵一阵地往下掉。

这一章短，是因为它和本栏目前几篇连在一起：高血压、糖尿病、高血脂、吸烟，就是伤脑血管的主要力量。读过《中风，真的是突然来的吗？》的弟兄姐妹会发现，**防中风和防血管性痴呆，几乎是同一套功课。**而且，阿尔茨海默病的人如果血管也不好，症状会来得更早、更重。所以，护血管就是护大脑。

08 为什么老了容易得

中国的全国调查，除了算有多少人得病，还比较了得病的人和没得病的人有什么不同[2]。和痴呆关系最明显的有这些：

因素	和痴呆的关联（比值比）
年纪越大	不同年龄组约 2.7—6.6 倍
父母得过痴呆	约 7.2 倍
得过脑血管病	约 5.4 倍
丧偶、离婚或独居	约 2.6—2.7 倍
糖尿病	约 2.1 倍
心脏病	约 2.0 倍
高血压、高血脂、吸烟	各约 1.9 倍
女性	约 1.4 倍
受教育年数少、住在农村	约 1.2—1.6 倍

要提醒一句：这是一次调查里的比较，看出的是“有关联”，不一定都是“因为所以”。比如独居，可能是孤独伤了大脑，也可能是已经开始糊涂的人，更少和人来往。

为什么年纪是最大的风险？编者把研究里常讲的几件事放在一起：

- **时间：**斑块和缠结要很多年才积起来，活得越久，越有机会积到出症状。
- **血管老了：**几十年的血压、血糖、胆固醇，在脑血管上留下的痕迹越来越多。
- **“储备”用掉了：**耳朵听不清、眼睛看不清、和人来往少了、活动少了，大脑得到的刺激少了，能顶上去的“备用线路”也少了。
- **修补的能力变差：**年纪大了，身体清理垃圾、修补损伤的能力都在下降，大脑也一样。

这张表里有一半以上的因素，是可以改变或者可以管的：血压、血糖、血脂、吸烟、孤独。调查的作者也说，其中有九项是可以改变的[2]。这就引出了第四部分要讲的预防。

第三部分

早一点发现

09 哪些信号要留意

痴呆来得慢，家里人天天在一起，反倒最不容易察觉。常常是过年回家的子女，一眼看出“妈和去年不一样了”。

下面这些信号，是编者参考各地常见的科普整理的。**一两次不算什么；如果变化持续了几个月、越来越明显，就该去看医生。**

1. **记不住新近的事，**同一件事反复问、反复说。
2. **做熟悉的事变难了：**做了几十年的菜，步骤乱了；用了多年的电视遥控器不会用了。
3. **弄不清时间和地点：**不知道今天几号、星期几，在熟悉的地方迷路。
4. **说话找不到词，**用“那个、那个东西”代替；跟不上别人的谈话。
5. **东西放错地方，**放在奇怪的地方，找不到就说别人偷了。
6. **判断力变差：**被推销的人骗着买了一大堆保健品，大冷天穿单衣出门。
7. **管不了钱：**算不清账，忘了交水电费，一笔钱重复给了好几次。
8. **不想出门、不想见人，**以前爱去的聚会、爱做的事都不去了。
9. **性格和情绪变了：**变得多疑、焦虑、容易发火，或者变得冷淡。
10. **开车、过马路时出现危险，**看不准距离，反应不过来。

有一个小办法：家里人可以把看到的变化写下来，什么时候、什么事、多少次。看病时拿给医生看，比一句“最近记性不好”有用得多。

突然变糊涂，是急事

痴呆是几个月、几年慢慢变的。如果老人**几小时或一两天之内突然糊涂了**，说胡话、白天睡晚上闹、一会儿清醒一会儿糊涂，那常常不是痴呆，而是“谵妄”：可能是感染（肺炎、尿路感染）、脱水、药物、摔了一跤以后颅内出血。要**当天就医**。如果同时有一侧手脚无力、口角歪斜、说话含糊，那可能是中风，**马上打 120**。

10 先排除能治好的原因

这一章可能是全篇最“值钱”的一章：**看起来像痴呆的，不一定都是痴呆；有些原因治好了，人就清楚了。**

医生看“记性差”的老人，常常会先查这些（编者整理，具体查什么由医生决定）：

维生素 B12 缺乏	老人胃酸少、长期吃某些胃药或二甲双胍、吃全素不补充的人，容易缺。缺了会手脚麻、记性差。抽血就能查，缺了补上。
甲状腺功能低下	人变得迟钝、怕冷、没精神、记性差。抽血能查，补甲状腺素就能改善。
抑郁	老人的抑郁常常不说“心情不好”，而是说“记不住、没意思、浑身不舒服”。治好抑郁，记性也常常回来。
药物的副作用	某些安眠药、抗过敏药、治尿频的药、止痛药，都可能让老人糊涂。第 20 章《小心几类常用的药》细讲。
听不清、看不清	听不清别人说什么，答非所问，看起来像糊涂。配好助听器、做了白内障手术，常常“清楚”了很多。
睡眠呼吸暂停	打鼾很响、睡觉时憋气、白天老打瞌睡的人，大脑夜里缺氧，白天记性和注意力都差。
正常压力脑积水	典型的三件事：走路像脚粘在地上一样拖着走、小便憋不住、记性差。做脑部 CT 或磁共振能看出来，有些人做引流手术后明显好转。
慢性硬膜下血肿	老人摔了一跤、碰了头，当时没事，几周后慢慢变糊涂、头痛、走路不稳。脑部 CT 能看出来，手术可以把血引出来。

最后一项和本栏目上一篇《骨质疏松与跌倒》连在一起：**老人摔了一跤以后几个星期变糊涂，一定要告诉医生“前些时候摔过”。**

编者的理解：这一章就是为什么“人老了都这样”这句话最耽误事。它让家里人不去查，也就错过了那些本来能治好的原因。

11 去哪里查、查什么

去哪里看？大医院的神经内科、老年科、精神科（心理科），很多都有“记忆门诊”或“认知障碍门诊”。社区医院也可以先做简单的筛查，再转诊。

医生一般会做这几件事：

1. **问病史：**什么时候开始的，怎样变的，有没有摔过、中过风，吃什么药。这时候家里人的观察最重要，最好有一位常在身边的人陪着去。

2. **做测验：**常用的有“简易精神状态检查”“蒙特利尔认知评估”等，问几个问题、记几个词、画个钟。几十分钟就能做完。测验成绩要结合文化程度看，读书少的老人，分数本来就会低一些。
3. **抽血：**查维生素 B12、甲状腺、血糖、肝肾功能等，排除第 10 章《先排除能治好的原因》里讲的原因。
4. **脑部影像：**CT 或磁共振，看有没有中风、出血、脑积水、肿瘤，海马有没有萎缩。
5. **需要时再查更专门的：**如果考虑用新的抗体药，要先证明脑子里确实有淀粉样蛋白，用的是特殊的 PET 检查或脑脊液检查；这几年也有抽血查相关蛋白的方法，正在逐步用到临床上。

很多老人不肯去，说“我又没病”。家里人可以换个说法：“去做个体检，查查血压和记性”，或者请老人信任的医生、亲戚、教会的长辈来劝。不要当着外人数落老人“糊涂了”，那只会让他更抗拒。

12 查出来了，要不要告诉他?

中国的家庭常常有一个习惯：老人得了重病，瞒着他，“怕他想不开”。痴呆也一样。

编者的理解：这件事没有一个统一的答案，要看老人的性格、病到哪一步、家里的情况。但有几个理由，值得家里人考虑**在早期、用温和的方式告诉他：**

- **趁他还能做决定。**钱怎样管、房子怎样处理、将来愿意住在家里还是去养老机构、病重时希望怎样治疗，这些事最好由他自己说了算。等到病重了，就再也问不了了。
- **他心里其实知道。**很多早期的病人自己察觉到不对劲，越是瞒，他越是害怕、越多疑。说开了，反而可以一起面对。
- **可以把时间花在重要的事上。**见想见的人，去想去的地方，把想说的话说出来，把一生的故事讲给孙辈听。

怎样说？不用一次说完，也不必用“痴呆”这样的词。可以说：“医生说你的记性生病了，就像血压高一样，要吃药、要锻炼，我们一起来对付它。”最重要的一句是：**“不管怎样，我们都陪着你。”**

第四部分

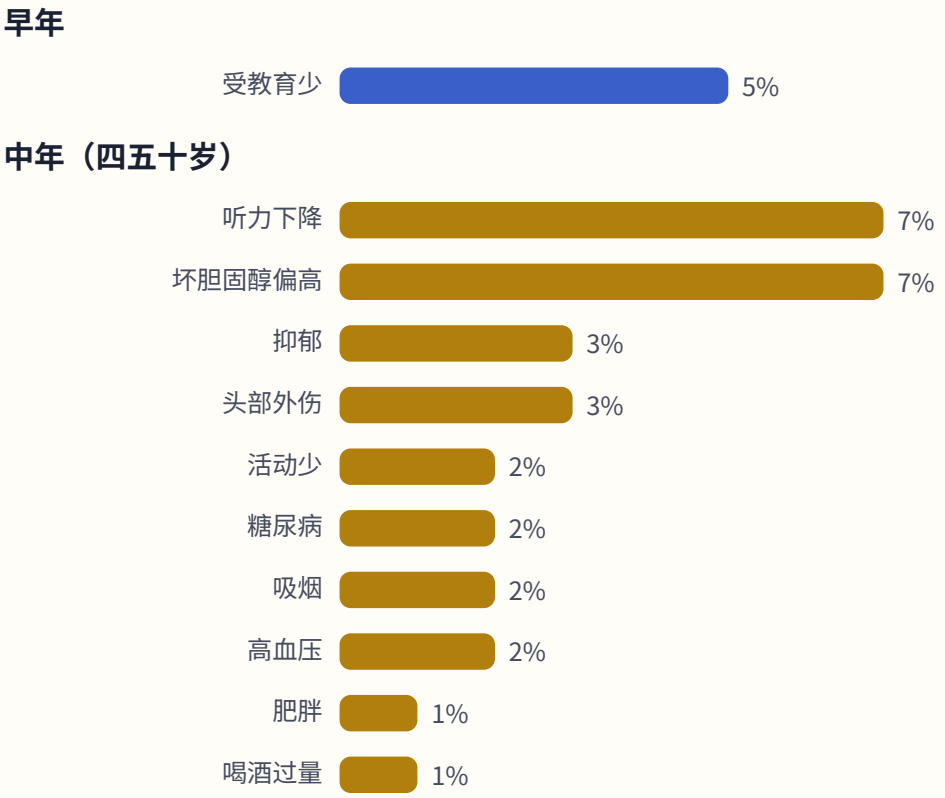
能预防吗：按证据的分量排

13 近一半，可能可以推迟或预防

预防痴呆，最常被引用的是英国《柳叶刀》杂志请几十位专家组成的“痴呆预防、干预和照护委员会”。2024 年，他们发表了最新的报告[4]。

报告把全世界的研究汇总起来，列出了**十四个可以改变的危险因素，**估计它们加起来约占全世界痴呆的**45%**。也就是说，如果这些因素全都消除，理论上将近一半的痴呆可以推迟或避免。

图 4 十四个可以改变的危险因素，各约占痴呆的多少



合计约 45%（估计）· 数据：Livingston 2024

这十四个因素，按人生的阶段排：

- **早年：**受教育少，约 5%。
- **中年，也就是四五十岁：**听力下降约 7%，“坏胆固醇”低密度脂蛋白偏高约 7%，抑郁约 3%，头部外伤约 3%；活动少、糖尿病、吸烟、高血压，各约 2%；肥胖、喝酒过量，各约 1%。
- **老年：**和人来往少、孤独，约 5%；空气污染约 3%；视力下降没有治，约 2%。

2024 年的报告比以前多了两项：坏胆固醇偏高和视力下降。而听力下降和坏胆固醇，各占了约 7%，排在最前面。

这些数字要怎样理解？有三点要说清楚：

1. **这是对一大群人的估计，不是对一个人的保证。**一个人把这十四件事都做到了，不等于他就一定不会得；反过来，有几项做得不好，也不等于一定会得。
2. **这是根据观察研究算出来的，**算的时候假设这些因素都是“因为所以”。真实的效果，要靠随机试验来证明。下面几章会一项一项看，哪些已经有试验，哪些还没有。
3. **不同地方，数字不一样。**湖北 8,827 名老人的分析，把 22 个因素算进去，和痴呆有关的部分约占 60%，农村比城市更高[5]；英国生物银行 34 万多人跟踪了 14 年，按这 14 个因素算出来约 41%[6]。方法不同，数字有高有低，但方向一致：**相当大的一部分，是可以努力的。**

> **— “受教育少”到了老年还能改吗？**
>
> 小时候读书少，老了确实改不了。研究者的解释是：读书多、用脑多的人，大脑里的“备用线路”多，同样多的病变，症状来得晚一些。所以这一条对老人的意义，是**继续学习、继续用脑**（第 19 章《用脑，和人来往》会讲）；对年轻的父母，是让孩子好好受教育。
>
> 中国的全国调查也看到，读书少的人更容易有痴呆和轻度认知障碍[2]。今天六七十岁的人，很多小时候没有机会多读书，这不是他们的错。编者的理解：这也提醒我们，在测验和看病时要体谅老人的文化程度，不要因为不识字就说人“糊涂”。

14 降血压：证据最硬的一件事

十四个因素里，到今天为止，**用大型随机试验直接证明“做了能少得痴呆”的，降血压是最硬的一项。**

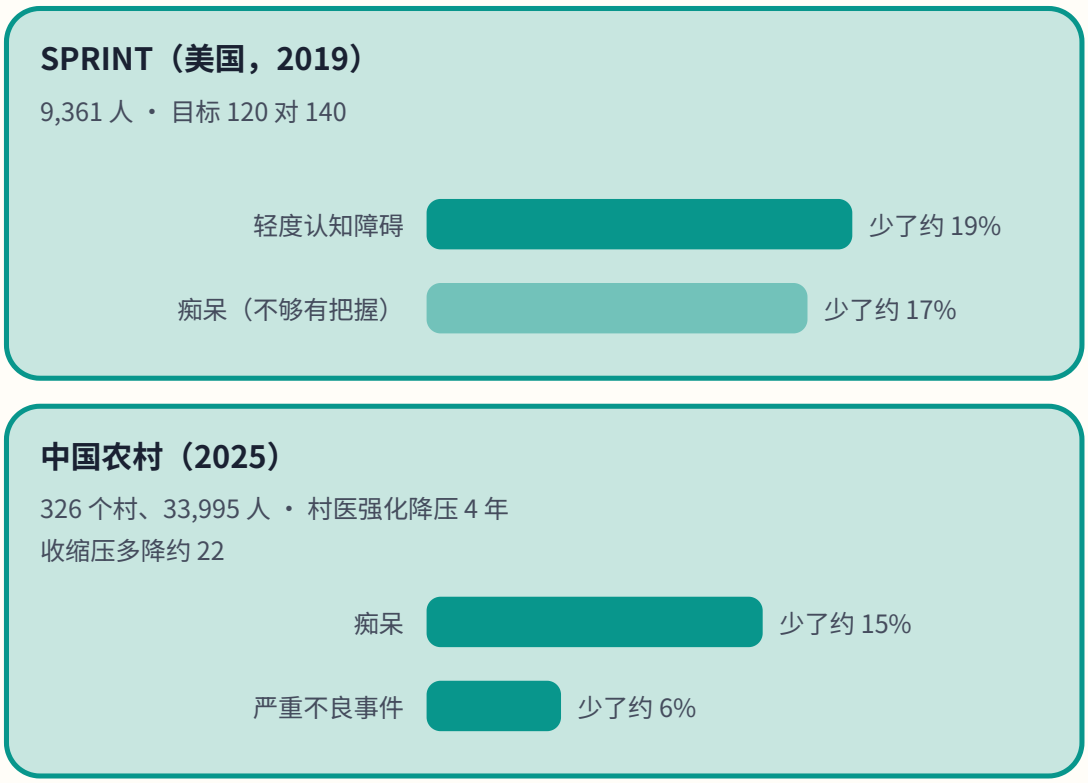
第一项是美国的 SPRINT 研究。9,361 名 50 岁以上、有高血压但没有糖尿病和中风的人，随机分两组：一组把收缩压（高压）降到 120 以下，一组降到 140 以下[7]。

- 降得更低的一组，**轻度认知障碍少了约 19%**，有统计学意义。
- 痴呆也少了一些（149 人对 176 人，少了约 17%），但还不够有把握，因为这个试验降压对心脏的好处太明显，提前停了，跟踪的时间不够长，得痴呆的人也比预想的少。研究者自己也说，这一项可能是“样本不够”。

第二项来自中国农村，2025 年发表[8]。这一项特别值得中国读者知道：

- 研究者在农村选了 326 个村，一半的村随机做“强化降压”，一半照常。一共 33,995 名 40 岁以上、血压没控制好的人。
- 做强化降压的村，**由受过培训的村医按照简单的步骤开药、加药，**上级医生指导，目标是降到 130/80 以下。
- 四年下来，强化组的收缩压比照常组多降了约 22，舒张压多降了约 9。
- **痴呆少了约 15%，**严重的不良事件也少了约 6%。

图 5 降血压能少得痴呆吗：两项随机试验



浅色的条＝差别还不够有把握 · 数据：Williamson 2019、He 2025

这项研究说明了两件事。第一，降血压确实能减少痴呆，而且在中国农村就能做到。第二，**不需要很贵的药、很大的医院，靠村医和社区医生，把血压量起来、药吃起来、按时加量，就能救下很多人的大脑。**

编者的理解：如果你只能记住这一篇的一件事，那就是这一件——**家里的高血压病人，把血压管好。**高血压怎样管，本栏目的《高血压，真的要吃一辈子药吗？》讲得很细。血压降多少合适，要和医生商量，尤其是八十岁以上、容易头晕摔倒的老人。

15 耳朵和大脑：听力为什么排第一

很多人想不到，听力下降竟然是十四个因素里排在最前面的一项（约 7%）[4]。

为什么耳朵和大脑有关？研究者提出了几种解释：听不清的时候，大脑要花很大力气去“猜”别人说什么，剩下做别的事的力气就少了；听不清，就不爱说话、不爱出门，越来越孤单；耳朵送进大脑的信号少了，管声音的那部分大脑也会萎缩。这些解释还在研究中。

那么，配助听器能不能减少痴呆？美国做了一项随机试验，叫 ACHIEVE[9]：

- 977 名 70—84 岁、听力下降但没有配过助听器的老人，一半配助听器、接受听力咨询，一半上健康讲座。
- 三年下来，**从全体来看，两组的认知下降几乎一样，**没有差别。

- 但是，研究预先设定的分析发现：在一群**年纪更大、危险因素更多、原来成绩更差**的老人里，配助听器的效果和另一群不一样，研究者认为对这样的高风险老人可能有帮助。

所以，说“配了助听器就能防痴呆”还太早。但编者的理解是：**听力下降本来就该治。**听得清，才能和家人说话、在教会里听道、唱诗、和朋友聊天；也不容易因为听不见车声而出危险。配助听器的好处，本来就不止是防痴呆。

关于听力，可以做的事

- 家里人说话老人常常“嗯？”，电视开得越来越大声，就带去查听力。
- 助听器要到正规的听力机构验配、调试，不要只在网上买一个塞上。头几个星期会不习惯，要多戴、多调。
- 年轻人少在嘈杂的地方待太久，耳机的音量不要开太大。听力一旦伤了，很难恢复。

16 眼睛：白内障和大脑

2024 年的报告新加了“视力下降没有治”这一项（约 2%）[4]。

美国有一项观察研究，跟踪了 3,038 名有白内障或青光眼的老人[10]。**做了白内障手术的人，以后得痴呆的风险低了约 29%。**

这是观察研究，可能有一个疑问：会不会是身体本来就好的人，才去做手术？研究者想了一个聪明的办法来检验：他们同时看了**青光眼手术**。青光眼手术是为了保住眼睛，不能让人看得更清楚。结果，做青光眼手术的人，痴呆风险没有降低。这说明，起作用的很可能真是“看得清楚了”，而不只是“愿意去做手术的人身体好”。

当然，这还需要更多研究来证实。编者的理解和听力一样：**白内障本来就该治。**看得清，才能读经、看书、认人、走路不摔跤。家里老人说“眼睛花了、像隔着一层雾”，就带去眼科看看。

17 多管齐下：芬兰和美国的两项试验

单一的一件事效果有限，那么同时做好几件呢？

芬兰的 FINGER 研究是这方面最有名的试验[11]。1,260 名 60—77 岁、痴呆风险偏高的人，随机分两组：

- 一组接受两年的“全套”：营养师指导饮食、教练带着做运动（包括力量练习）、电脑上做认知训练，定期查血压、血糖、血脂；
- 另一组只得到一般的健康建议。

两年后，全套组的认知测验成绩比对照组好一些，差别不大，但有统计学意义。代价是：全套组有约 7% 的人出现不良事件，最常见的是运动引起的肌肉和关节疼痛，对照组约 1%。

美国的 POINTER 研究是 FINGER 在美国的“升级版”，2025 年发表[12]。2,111 名 60—79 岁、平时不爱动、饮食不太好、还有其他危险因素的人，两组都被鼓励多运动、吃得健康、多用脑、多和人来往、管好心血管，区别在于：

- **有组织的一组：**固定的时间、教练带着练、小组聚会、有人跟进和督促；
- **自己来的一组：**给资料、给建议，自己安排。

两年后，**两组的认知成绩都比开始时好了，**有组织的一组好得更多一些。差别同样不大，但比较可靠；原来成绩越差的人，从有组织的方案里得益越多。研究里另做了脑部影像，两组的大脑影像指标没有看到差别[13]。

图 6 预防痴呆的办法，证据有多硬



越往上，越有把握；

下面几层的事，对血管、心情、防跌倒多半也有好处

编者根据本篇引用的研究整理

这两项试验告诉我们什么？编者的理解：

- **生活方式的改变有用，但效果是“一点一点”的，**不是吃一种神药那样立竿见影。

- **有人陪着、有人督促，比自己一个人坚持效果更好。**这一点对教会特别有意义：一起散步、一起做饭、一起读经唱诗，本身就是“有组织的方案”。
- 两年太短。痴呆要很多年才出来，这些试验现在测到的是认知成绩的变化，能不能真正减少痴呆，还要更长时间的跟踪。

18 动起来，睡够觉

先说活动。英国生物银行有 78,430 名 40—79 岁的人，戴着手环记录了每天走多少步，然后跟踪了约 7 年[14]：

- 每天走约 **9,800 步**的人，痴呆风险最低，约低了一半；
- 每天约 **3,800 步**，风险就已经低了约四分之一；
- 同样的步数，走得快一点、有目的地走（比如快步去买菜），关联更强。

这是观察研究。不能排除一部分是“已经开始糊涂的人，本来就走得少”。但运动对血压、血糖、心情、睡眠、防跌倒都有好处，这些好处是试验证明过的。编者的理解：**不用一下子追求一万步，从现在的步数每天多走一点就好。**腿脚不好的老人，坐着抬腿、扶着椅子站起坐下，也算。

再说睡眠。英国的“白厅第二期研究”跟踪了 7,959 名公务员 25 年[15]。50 岁、60 岁时每晚只睡 6 小时或更少的人，以后得痴呆的风险比睡 7 小时的人高；50、60、70 岁一直睡得短的人，风险高了约 30%。

这也是观察研究，但它提醒我们：**中年时长期熬夜、睡得太少，可能在给二十年后的大脑记账。**打鼾很响、睡觉憋气的人，要查一查睡眠呼吸暂停（第 10 章《先排除能治好的原因》讲过）。至于老人睡不着，先别急着吃安眠药，下面第 20 章《小心几类常用的药》会讲为什么。

编者的理解：安息日的意义之一，就是承认人是受造的，需要休息。

> 他就说：“你们来，同我暗暗地到旷野地方去歇一歇。”这是因为来往的人多，他们连吃饭也没有工夫。
>
> 马可福音 6:31

19 用脑，和人来往

“越用越灵”有没有根据？美国有一项上世纪九十年代末开始的随机试验，叫 ACTIVE，把两千多名老人分成几组，分别做记忆训练、推理训练、“反应速度”训练，或者不做训练。每种训练只上了几周的课，有些人以后再加几次“加强课”。

2026 年发表的 20 年跟踪结果[16]：

- 做了“反应速度”训练、**还上过加强课的人，**20 年里被诊断痴呆的风险低了约 25%；
- 做了速度训练但没上加强课的人，没有差别；
- 记忆训练和推理训练，没有看到差别。

同一年也有学者重新分析了这些数字，指出比较的组别很多，按更严格的统计方法校正后，每一组单独看都不算有把握；但他也认为，几种训练的方向大体一致，可能都有一点保护作用，主要在较年轻的老人身上[17]。所以，这个结果值得重视，但还不能说已经定论。

再说和人来往。孤独和社交少，是十四个因素里排在前面的一项（约 5%）[4]；中国的全国调查里，丧偶、离婚或独居的老人，痴呆的比例明显更高[2]。

编者的理解：用脑和交往，最好的方式不是一个人在手机上做“脑力游戏”，而是**有意思、有挑战、有人一起**的事：学一门新手艺、学乐器、学写字画画、带孙辈、做志愿者、参加查经班和诗班。背经文、唱诗，既用脑，又有伙伴，又有盼望。

对独居的老人，家里人能做的最简单的事，就是**常打电话、常回家、常带他出门。**教会也可以安排弟兄姐妹定期探访。

20 小心几类常用的药

这一章要特别请家里有老人的读者注意：**有些很常见的药，可能让老人糊涂。**

第一类：“抗胆碱”作用强的药。大脑里有一种叫“乙酰胆碱”的物质，和记忆关系很大。有些药会挡住它的作用。英格兰的一项大型研究，比较了 58,769 名痴呆病人和 22 万多名没有痴呆的人，看他们过去十年吃的药[18]：

- 抗胆碱作用强的药吃得越多，痴呆的风险越高；吃得最多的一组（相当于三年以上天天吃），风险高了约 49%。
- 关联比较明显的有：某些抗抑郁药、治帕金森的药、抗精神病药、**治尿频尿急的膀胱药、**某些抗癫痫药。

常见的抗胆碱药还有一些老的抗过敏药、晕车药、感冒药里的某些成分（比如苯海拉明、氯苯那敏），老人常常不知不觉吃了很多。

第二类：安定类的安眠药和抗焦虑药（名字常带“西泮”“唑仑”，比如地西泮、阿普唑仑、艾司唑仑）。这一类药研究的结果**两边都有：**

- 加拿大魁北克的研究发现，用过这类药的老人，阿尔茨海默病的风险高了约 51%，用得越久、越是长效的药，关联越强[19]。
- 美国西雅图的研究跟踪了 3,434 名老人，发现用得少的人风险略高，**用得最多的人反而没有更高，**不像“药越多越伤脑”的样子；作者认为结果不支持因果关系[20]。

为什么会这样？一个可能是：痴呆早期的人常常睡不好、焦虑，所以先吃上了安眠药，看起来像“吃药导致痴呆”。到今天还没有定论。但有一件事是确定的：这类药让老人白天昏沉、反应慢、**更容易摔跤，**而摔跤对老人很危险。

这两类研究都是观察研究，不能证明药一定导致痴呆。但编者的理解是：**老人吃的每一种药，都值得问一问“还需要吗”。**

千万不要自己突然停药

- 安眠药、抗焦虑药、抗抑郁药、抗癫痫药，**突然停掉可能很危险，**要在医生指导下慢慢减。
- 可以做的是：把老人吃的所有药（包括中成药、保健品、药店买的感冒药）装在一个袋子里，带去给医生或药师看一遍，问哪些可以减、可以换。
- 睡不着，先试试不用药的办法：白天多晒太阳、多活动，午睡不超过半小时，晚上少喝茶和咖啡，按时上床起床。

21 还有哪些说法：疫苗、减肥针、喝酒、头部外伤

带状疱疹疫苗。2025 年《自然》杂志发表了一项很巧妙的研究[21]。英国威尔士规定，1933 年 9 月 2 日以后出生的老人可以打带状疱疹疫苗，以前出生的不行。于是，只差一个星期出生的两群人，一群打疫苗的有 47%，一群几乎没人打。研究发现，可以打疫苗的那群人，七年里新诊断痴呆的少了约 3.5 个百分点，相对少了约 20%，女性更明显。

这种“自然实验”比一般的观察研究更有说服力。但 2026 年也有研究者泼了冷水[22]：他们把威尔士、澳大利亚、加拿大几项类似研究的结果换算成“打了疫苗的人少了多少痴呆”，有的算出来超过了 100%，这是不可能的；而且这些国家推行疫苗以后，全国的痴呆发病并没有看到相应的下降。他们认为，这些研究还不能算强证据。

编者的理解：打带状疱疹疫苗，本来就是为了防带状疱疹和它留下的神经痛，这个好处是确定的。能不能防痴呆，还要等更多研究。适不适合打，可以问医生。

司美格鲁肽（“减肥针”“降糖针”）。有观察研究看到，用这类药的糖尿病人，后来得痴呆的少。药厂就做了两项大型随机试验，给早期阿尔茨海默病人吃两年口服的司美格鲁肽。**结果都没有看到临床上的好处**[23]。这是一个很好的例子：观察研究里看到的“关联”，放到试验里不一定站得住。

喝酒。十四个因素里有“喝酒过量”（报告里指每周超过约 21 个标准单位）[4]。有人说“少量喝酒护脑”，本栏目《中风》一篇讲过，中国 50 万人的基因研究不支持“少量喝酒有保护作用”。编者的理解：不喝最好。

头部外伤。中年时的头部外伤约占 3%[4]。骑电动车、摩托车戴头盔，干活注意安全，老人防跌倒，都是在保护大脑。

抑郁。约占 3%[4]。抑郁可能是痴呆的风险，也可能是痴呆的早期表现。不管哪一种，抑郁本身就该好好治。

第五部分

吃什么、补什么

22 吃什么：一项让人意外的试验

说到预防痴呆，很多人第一个想到的是“吃什么补脑”。

美国有一种饮食叫“MIND 饮食”，是地中海饮食和防高血压的 DASH 饮食的结合，特别强调绿叶菜、浆果、坚果、豆类、全谷物、橄榄油，少吃红肉、黄油、油炸食品和甜点。观察研究里，吃得越接近这种饮食的人，认知下降越慢。

2023 年，研究者做了一项随机试验来验证[24]。604 名有痴呆家族史、超重、饮食不太好的老人，随机分两组，一组吃 MIND 饮食，一组照常吃，**两组都稍微少吃一点、都在减重**。三年后：

- 两组的认知成绩都比开始时好了；
- **两组之间没有差别，**脑部磁共振的变化也差不多。

这个结果让很多人意外。怎样理解？编者的理解：

- 可能是对照组也在减重、也被关心，本身就有好处，把差别“抹平”了；
- 可能是三年太短，或者这些老人认知本来就正常，看不出差别；
- 也可能是，单靠换一种饮食，对大脑的作用没有我们以为的那么大。

所以，**没有哪一种食物、哪一种饮食，被证明能单独防住痴呆。**但吃得清淡、少盐少油、多蔬菜水果豆类全谷物，对血压、血糖、血脂、体重的好处是确定的，而这些正是伤大脑的力量。编者的理解：好好吃饭，是在护血管；护了血管，也就护了大脑。

一 复临信徒的研究：吃素的人痴呆少吗？

美国加州的复临信徒健康研究，1993 年发表过一项初步的分析[25]。研究者找了 272 名复临信徒，按年龄、性别、住址配成 68 组，每组一个纯素食者、一个蛋奶素食者、两个吃肉多的人。结果，吃肉（包括禽肉和鱼）的人得痴呆的风险约是素食者的 2.18 倍，但还不够有把握（p＝0.065）；把过去吃肉的年数也算进去，差距更大（约 2.99 倍）。

可是在另一组没有配对的 2,984 人里，吃素和吃肉的人，痴呆的发生没有明显差别。研究者说，两组结果不一致的原因不清楚。两组里都有一个趋势：吃素的人发病晚一些。

编者的理解：这是三十多年前的初步研究，人数少、结果不一致，不能拿来说“吃素就不会痴呆”。可以说的是，复临信徒健康研究在血压、血糖、血脂、寿命上的发现（本栏目前几篇讲过），都指向

同一个方向：**植物为主、不吸烟不喝酒、规律生活，对血管有益。**吃全素的人要注意补维生素 B12（第 10 章《先排除能治好的原因》讲过）。

23 银杏、鱼油和“补脑”产品

银杏。银杏叶提取物是世界上最常被买来“补脑”的东西之一。美国做过一项很大的随机试验[26]：3,069 名 75 岁以上的老人，一半每天两次吃 120 毫克银杏叶提取物，一半吃安慰剂，跟踪了约六年。

- 吃银杏的一组，得痴呆的有 277 人；吃安慰剂的一组，246 人。**银杏没有减少痴呆，**也没有减少阿尔茨海默病；
- 对已经有轻度认知障碍的人，银杏也没有让他们少发展成痴呆。

2026 年考克兰（一个专门做证据汇总的国际组织）把 82 项试验、一万多人汇总起来[27]：对轻度认知障碍的人，银杏**可能几乎没有效果**（中等确定性）；对已经得了痴呆的人，半年里可能有小到中等的好处，但证据的确定性低，各项研究的结果差得很远，而且大部分研究质量不高。

其他“补脑”产品。市面上有各种“健脑”“益智”“改善记忆”的保健品、口服液、“深海鱼油”、磷脂、“脑黄金”。编者在 PubMed 上没有找到哪一种产品，在高质量的大型随机试验里被证明能预防或治疗痴呆。**保健品不是药，不能用来治病。**

特别提醒：老人是保健品骗局的主要对象

- 痴呆早期的老人判断力下降，最容易被“免费体检”“健康讲座”“送鸡蛋”吸引，一买就是几万元。
- 凡是说“能治老年痴呆”“能让脑细胞再生”“停了西药吃这个”的，都要警惕。
- 家里人不要只是责备老人“乱花钱”，而要多陪伴、多打电话；老人的钱，可以和他商量着一起管。

那维生素呢? 缺什么补什么：查出维生素 B12 缺乏的，补 B12 有用（第 10 章《先排除能治好的原因》）；不缺的人多吃，没有证据能防痴呆。

24 中医中药

很多家庭会想到中医。中医讲“健脑益智”“补肾填精”，有不少方剂和中成药。

中医中药治痴呆，研究不少，但好的大型试验不多。2025 年一篇系统综述汇总了 13 项研究[28]：中药组的认知测验分数比对照组好一些，但在精神行为症状和日常生活能力上，没有看到差别。作者自己也说，要更大、设计更严谨、跟踪更久的研究来确认。

编者的理解：

- 中药治痴呆，目前**还没有像降血压防痴呆那样硬的证据。**很多研究人数少、时间短，不是双盲的，结果容易偏向好的一面。
- **中药也是药，**也有副作用。本栏目《骨质疏松》一篇讲过，有的中成药会伤肝。老人同时吃很多种药，更要小心。
- 如果想用，**到正规医院的中医科看，**并且告诉每一位医生你在吃什么，不要停掉医生开的西药去换中药。
- “针灸、按摩、太极”这一类，如果能让老人动起来、和人来往、心情好，本身就有好处；但不要寄望它们能“治好”痴呆。

第六部分

药物：老药、新药和争议

25 改善症状的老药

先说一句实话：**到今天为止，还没有能“治好”阿尔茨海默病的药。**现有的药，一类是改善症状，一类是减慢病情。

改善症状的药，用得最久的是“胆碱酯酶抑制剂”，比如多奈哌齐，还有卡巴拉汀、加兰他敏。它们的道理是：阿尔茨海默病人脑子里管记忆的乙酰胆碱少了，这类药让它分解得慢一点，留得多一点。

考克兰汇总了多奈哌齐的 30 项随机试验、8,257 人[29]：

- 用药半年左右，认知测验成绩**小幅度地好一些**（比如满分 30 分的简易精神状态检查，平均好约 1 分），日常生活能力和医生评估的总体情况也好一点；
- 在情绪行为问题和生活质量上，没有看到差别；
- 副作用多一些：72% 对 65% 的人有不良反应，常见的是恶心、腹泻、没胃口、做梦多、心跳慢；中途停药的也多一点。
- 大剂量（23 毫克）并不比 10 毫克更好，副作用反倒更多。

中重度的病人，医生也可能用美金刚，或者两类药一起用。

编者的理解：这些药的作用不大，但对一部分病人，“好一点”可能意味着多认得家人一段时间、多自己吃饭一段时间。用不用、用多久，要和医生一起看效果和副作用来决定。心跳本来就慢、容易晕倒的老人，要特别告诉医生。

26 新药：清除淀粉样蛋白的抗体

这几年最大的新闻，是两种“抗体药”：仑卡奈单抗和多奈单抗。它们是针对β-淀粉样蛋白的抗体，打进身体里，帮着把大脑里的斑块清除掉。在中国，它们分别在 2024 年 1 月和 12 月获批，用于阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和轻度痴呆[30]。

它们到底有多大用？看两项关键的试验。

仑卡奈单抗：1,795 名早期病人，每两周打一次点滴，18 个月[31]。

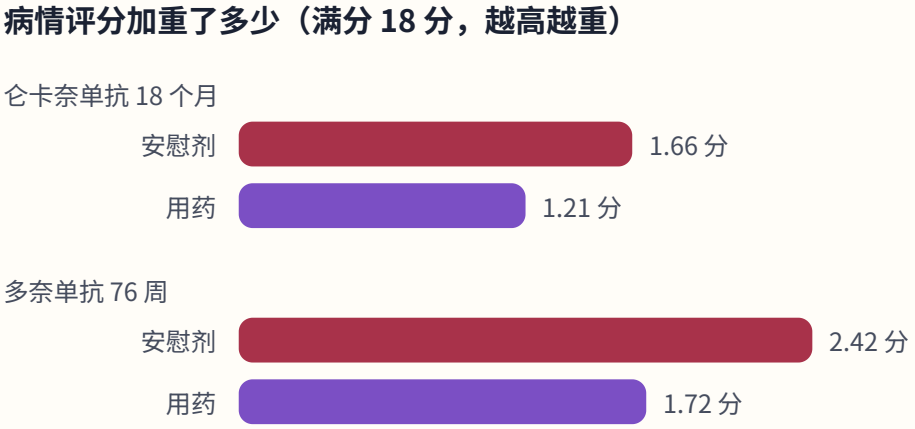
- 大脑里的淀粉样蛋白明显减少；

- 病情评分（满分 18 分，分数越高越重）：用药组 18 个月加重了 1.21 分，安慰剂组加重了 1.66 分，**差 0.45 分；**
- 约 26% 的人打针时有反应（发热、发冷、头痛等）；约 12.6% 的人**脑部磁共振上出现水肿或渗出**（叫“淀粉样蛋白相关影像异常”）。这种改变有时没有感觉，有时会引起头痛、糊涂、视力变化等症状。
- 研究由药厂卫材和渤健资助。研究者的结论是“中等程度地减少了下降”，同时有不良反应，要更长的试验来确定。

多奈单抗：1,736 名早期病人，每四周打一次点滴，76 周；脑子里的斑块清除到一定程度就换成安慰剂[32]。

- 同一种病情评分，全体病人里用药组加重了 1.72 分，安慰剂组加重了 2.42 分，**差约 0.7 分；**
- 约 24% 的人出现脑水肿或渗出（安慰剂组约 2%），其中 52 人有症状；用药组有 3 人的死亡被认为和治疗有关（安慰剂组 1 人）。
- 研究由礼来公司开展。

图 7 两种新抗体药：好处有多大，风险有多大



加重的速度慢了约四分之一到三成：是“慢一点”，不是“好起来”

风险	仑卡奈	多奈
脑水肿或渗出（磁共振上）	**约 12.6%**	**约 24%**
打针时的反应	**约 26%**	**约 9%**

只用于早期、证实有淀粉样蛋白的病人；要定期做磁共振

数据：van Dyck 2023（卫材、渤健资助）、Sims 2023（礼来开展）

这些数字怎样理解？编者按摘要里的数字算了一下：**两种药让病情加重的速度慢了约四分之一到三成。**这是真实的好处，也是第一次在大型试验里证明，有药能改变这个病的进程。但要清楚几件事：

- **是“慢一点”，不是“停下来”，更不是“好起来”。**病还在往前走。
- **只适合早期的病人，**而且要先用 PET 或脑脊液等检查证实脑子里确实有淀粉样蛋白。中重度的病人不适合。
- **要定期做磁共振**监测脑水肿和出血；在吃抗凝药（防血栓的药）的人，出血的风险需要特别评估。
- 要定期去医院打点滴，费用也不低。

编者的理解：如果家里人是早期病人，可以去有条件的记忆门诊问一问，自己适不适合；如果医生说不适合，也不必失望。照护、降血压、活动、陪伴，这些对每一位病人都有用。

27 “九期一”的来龙去脉

说到治痴呆的药，很多中国家庭听说过“九期一”，也就是甘露特钠胶囊（研发代号 GV-971）。它的来龙去脉，是一个理解“证据”很好的例子。

- **2019 年 11 月，**国家药监局**有条件批准**它上市，用于轻中度阿尔茨海默病，同时要求企业上市后继续研究它的作用机制和长期的安全性、有效性[33]。当时被报道为“全球 17 年来第一个获批的阿尔茨海默病新药”，也引起了不少争议。
- **2021 年，**中国的三期试验正式发表[34]：818 名轻中度病人，36 周；认知评分比安慰剂组好了约 2 分（满分 70 分），不良反应两组差不多。作者里有企业的员工。
- **2025 年，**据媒体报道，这个药的注册证到期后停产，同年 8 月再注册的申请没有获得批准；企业方面说，确证性的研究还在进行[35]。

编者的理解：

- “有条件批准”的意思是，证据还不够完整，先让急需的病人用上，但要继续拿出更多证据。一个药的证据，要经得起更多、更大、更独立的研究检验。
- 这个药后来能不能再上市，要看后续研究的结果和国家药监局的决定，以官方公布为准。
- 如果家里老人原来在吃这个药，现在买不到了，**请去看医生，商量换用其他已经批准的药，**不要自己去网上找来路不明的“替代品”。

第七部分

照护：病人、家人和教会

28 日常相处：几句话、几件事

痴呆是一条很长的路，常常要走很多年。药物能做的有限，**真正撑起这段路的，是每天的照顾和陪伴。**

说话的方法：

- **不争对错。**老人说“今天我妈来看我了”（他的母亲早已去世），与其纠正“你妈早死了”，让他再伤心一次，不如问：“你想妈妈了？跟我说说她。”
- **一次说一件事，**句子短、说慢一点；问“喝水还是喝牛奶？”比问“你想喝什么？”容易回答。
- **不考他。**“你还记得我是谁吗？”“昨天吃了什么？”这样的问题，会让他难堪和紧张。可以先说：“爸，我是小明，来看你了。”
- **看他的感受，不只看他的话。**他说不清楚的时候，留意表情和动作：是累了、饿了、痛了，还是害怕了？

生活的安排：

- 每天的作息尽量固定：几点起床、吃饭、散步、午休。熟悉的规律让他安心。
- 让他做还能做的事：叠衣服、择菜、浇花、擦桌子。**被需要的感觉，**对病人很重要。
- 放他熟悉的老照片、老歌、熟悉的诗歌。照顾者常常发现，很多病人别的都忘了，年轻时唱熟的歌、背熟的经文还记得。

安全的安排：

- **防走失：**衣服里放写着姓名和家人电话的卡片，或者戴有联系方式的手环、带定位的设备；准备一张近照，万一走失马上报警。
- **厨房：**燃气灶装熄火保护或定时关阀，必要时换成电磁炉。
- **药：**用分格的药盒，由家人每周分好，看着吃。
- **钱和证件：**银行卡、存折由家人协助保管；提醒老人不接陌生电话、不给陌生人转账。
- **开车：**出现迷路、反应慢，就要停止开车。这件事常常最难开口，可以请医生来说。
- **防跌倒：**痴呆的老人更容易摔，本栏目《骨质疏松与跌倒》里讲的家里改造，同样适用。

29 脾气变了、晚上闹，怎么办

很多家属说，最难的不是老人忘事，而是**脾气变了：**多疑、骂人、怀疑东西被偷、傍晚以后特别烦躁、晚上不睡觉到处走、甚至打人。

这些叫“精神行为症状”，是这个病的一部分，不是老人故意找麻烦。先记住一句话：**他不是在跟你作对，他是在跟病作对。**

遇到这些情况，先找原因（编者整理的常见原因）：

- **身体不舒服但说不出来：**疼痛、便秘、尿路感染、饿了、渴了、太冷太热。很多“闹”，是身体在喊痛。
- **听不清、看不清，**误会了别人的话和动作。
- **环境变了：**换了住处、来了生人、太吵太乱。
- **累了、无聊了：**白天睡太多，晚上就不睡；整天没事做，就容易烦躁。
- **药物：**新加的药或者换了药以后变了样，要告诉医生。

然后试试不用药的办法：转移注意力（一起看老照片、听歌、出去走走）、让环境安静明亮、白天多活动多晒太阳、傍晚开灯早一点。

如果这些都试过了，症状还是很重，甚至有危险（伤人、伤己），医生可能会用一些药。要知道，**抗精神病类的药用在痴呆老人身上，药品说明书里有增加中风和死亡风险的警告，**所以要用最小的剂量、最短的时间，并且定期评估能不能减停。不要自己去药店买安定类的药给老人“镇一镇”。

30 照顾的人，也需要被照顾

照顾痴呆病人，是一件极其辛苦的事。很多照顾者是老伴，自己也七八十岁了；或者是中年的子女，上有老、下有小，还要上班。日复一日，没有休息，没有尽头，还常常被病人误会、责骂。

照顾者自己累垮、抑郁、生病，是很常见的事。所以这一章想对照顾者说几句话：

- **你累，不是你不孝、不爱。**累了、烦了、甚至有时候心里冒出“什么时候是个头”的念头，都是人之常情，不必为此自责。
- **不要一个人扛。**兄弟姐妹要分担，钱出钱、力出力，轮流照顾；请钟点工、日间照料中心、短期托养，让主要照顾的人每周至少有喘口气的时间。
- **学一点照护的知识。**很多医院、社区有照护者课程和互助小组，知道病会怎样变，心里有了准备，就不那么慌。
- **照顾好自己的身体。**你的血压、你的睡眠、你的体检，也很重要。你倒下了，病人怎么办？

- **送去专业机构不是抛弃。**病到后期，需要专业的护理，家里实在照顾不了，选一家好的机构、常去探望，也是一种爱。

对教会来说，这是实实在在可以做的事：

> 你们各人的重担要互相担当，如此，就完全了基督的律法。
>
> 加拉太书 6:2

弟兄姐妹可以轮流去陪一陪病人，让照顾者去买个菜、睡个午觉、来参加一次聚会；可以帮忙接送看病；可以为照顾者祷告，也常常问一句：“你最近怎么样？”很多照顾者最需要的，不是建议，而是有人听他说说话。

31 当他忘了自己，上帝也不忘记他

痴呆最让家人心痛的，是看着一个熟悉的人，慢慢“不见了”。他忘了家人的名字，忘了自己的过去，有一天也许连镜子里的自己都认不出来。

很多信徒心里还有一个更深的问题：**如果他连上帝都忘了，连祷告都不会了，他还属于上帝吗？**

圣经给我们的安慰是：我们和上帝的关系，最终不是靠我们记得祂，而是靠祂记得我们。

> 15 妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜恤她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。 16 看哪，我将你铭刻在我掌上；你的墙垣常在我眼前。
>
> 以赛亚书 49:15—16

母亲也许会忘记孩子，上帝说：“我却不忘记你。”我们的名字，刻在祂的掌上。

> 13 父亲怎样怜恤他的儿女，耶和华也怎样怜恤敬畏他的人！ 14 因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土。
>
> 诗篇 103:13—14

祂知道我们是尘土做的，知道我们的大脑会衰老、会生病。祂并不因此离弃我们。

> 直到你们年老，我仍这样；直到你们发白，我仍怀抚。我已造作，也必保抱；我必怀抱，也必拯救。
>
> 以赛亚书 46:4

编者的理解：一个人的价值，不在于他记得多少、能做多少，而在于他是上帝按着自己的形象所造、基督为他舍命的人。一位得了痴呆的老人，即使说不出完整的话，也仍然是我们的父亲、母亲、弟兄、姊妹。

耶稣在十字架上，在最痛苦的时候，还记挂着自己的母亲，把她托付给门徒：

> 26 耶稣见母亲和他所爱的那门徒站在旁边，就对他母亲说：“母亲，看，你的儿子！”
> 27 又对那门徒说：“看，你的母亲！”从此，那门徒就接她到自己家里去了。
>
> 约翰福音 19:26—27

照顾一位渐渐忘记的人，就是在走耶稣走过的这条路。

保罗说：

> 16 所以，我们不丧胆。外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。 17 我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。 18 原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的；因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。
>
> 哥林多后书 4:16—18

外面的人一天天衰败，这是我们看得见的；但在上帝那里，还有我们看不见、却永远的东西。复临信徒相信，有一天主再来的时候，死了的人要复活，衰老和疾病都要过去。那一天，病人会重新认得我们，我们也会重新认得他。

第八部分

一生的功课与结语

32 每个年纪能做的事

痴呆的根，常常在几十年前就种下了。所以，保护大脑是一生的功课，每个年纪都有能做的事：

图 8 保护大脑是一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **孩子和年轻人：**好好读书、多读书，这是一辈子的“大脑储备”；骑车戴头盔，保护头部；耳机音量别开太大；不吸烟。
- **四五十岁：**这是最关键的年纪。量血压、查血脂和血糖，有问题就认真管；听力下降就去查、该配助听器就配；戒烟、少酒或不喝；多运动、保持体重；睡够觉；抑郁了要治。

- **六十五岁以上：**继续管好血压；每年查听力和视力，白内障该做手术就做；和人来往，参加教会和社区的活动；学点新东西；请医生把所有的药审一遍，少用安眠药和抗胆碱药；防跌倒。
- **已经有轻度认知障碍或早期痴呆：**先查有没有能治好的原因；在医生指导下考虑用药；趁早安排好钱和照护的事；坚持活动和交往；家里人学会怎样相处。

编者的理解：这份清单里，几乎每一件事也同时在防中风、防心脏病、防糖尿病、防跌倒。**护大脑和护全身，是同一件事。**

> 你趁着年幼、衰败的日子尚未来到，就是你所说，我毫无喜乐的那些年日未曾临近之先，当记念造你的主。
>
> 传道书 12:1

33 常见问题

老人经常忘事，是不是就是老年痴呆？

不一定。偶尔忘事、提醒一下就想起来，多数是正常的老化。如果同一件事反复问、在熟悉的地方迷路、做熟悉的事变难了，并且持续几个月、越来越明显，就该去记忆门诊或神经内科查一查。

父母有老年痴呆，我是不是一定会得？

不是。父母得过，自己的风险会高一些[2]，但大多数痴呆是许多基因和生活一起作用的结果。家族史是提醒你更早管好血压、血糖、听力、睡眠和运动的理由。

痴呆能治好吗？

有一部分“看起来像痴呆”的情况能治好，比如维生素 B12 缺乏、甲状腺功能低下、抑郁、药物副作用、正常压力脑积水、硬膜下血肿。真正的阿尔茨海默病目前还不能治好，但有药能改善症状或减慢病情。

每天做数独、玩“脑力游戏”能防痴呆吗？

有一项 20 年的试验发现，反应速度训练加上加强课的人，痴呆诊断少了约四分之一[16]，但这个结论还有争议[17]。比起一个人玩游戏，学新东西、和人一起活动、多走路，可能更有意义。

银杏、鱼油、“脑黄金”能补脑吗？

银杏在 3 千多名老人身上用了约六年，没有减少痴呆[26]。编者没有找到哪一种“补脑”保健品在高质量的大型试验里被证明能防治痴呆。缺维生素 B12 的人补 B12 有用。

安眠药吃了好几年，会不会得痴呆？要不要马上停？

研究结果两边都有[19][20]，还没有定论；但这类药会让老人昏沉、更容易摔。千万不要突然停药，要请医生帮着慢慢减，同时试试白天多活动、多晒太阳这些不用药的办法。

新药仑卡奈单抗、多奈单抗适合我家老人吗？

只适合早期（轻度认知障碍或轻度痴呆）、而且检查证实脑子里有淀粉样蛋白的阿尔茨海默病人；要定期打点滴、做磁共振，有脑水肿的风险。可以去有条件的记忆门诊问医生。

老人说有人偷了他的东西，要不要跟他讲道理？

编者的理解：不必争辩。先安抚他的情绪：“别急，我帮你一起找。”找到了就好；平时可以把常用的东西放在固定的地方，贵重的东西由家人保管。

家里老人得了痴呆，还要带他去教会吗？

只要他愿意、身体允许，可以带。熟悉的诗歌、熟悉的面孔，常常能让他安心。可以坐在靠门口、方便出入的位置，时间太长就提早离开。也可以请弟兄姐妹到家里来，一起唱诗祷告。

34 结语：不是“人老了都这样”

回到开头的王阿姨。

女儿后来带她去了记忆门诊。医生问了很多问题，做了测验，抽了血，拍了磁共振。结果是：轻度认知障碍，同时缺维生素 B12，血压也一直没控制好。医生给她补了 B12，调了降压药，让她把每天吃的一种安眠药慢慢减掉，还建议她每天出去走走，回教会的诗班唱歌。

半年后复查，她的测验成绩好了一些。她还是会忘事，但不再站在路口发呆了。女儿说：“要是当初信了‘人老了都这样’，就耽误了。”

这个故事是编者为了说明而写的，不是每一位病人都能这样好转。有的人查出来就是阿尔茨海默病，会慢慢往下走。但不管是哪一种，**早一点去查，总是比不查好。**

最后，把这一篇浓缩成几句话：

- 病人越来越多，主要是活到老年的人多了；同样年纪的人，风险其实在降。**老了不等于一定会痴呆。**
- **突然变糊涂是急事；**慢慢变糊涂，要先查能治好的原因。
- 十四个可以改变的因素，加起来约占 45%。**证据最硬的是降血压；**听力、视力、活动、睡眠、交往、少用伤脑的药，都值得做。
- “补脑”保健品没有可靠的证据；新药有用，但不大，只适合早期病人。
- 照顾病人的人，也需要被照顾。

> 我年老的时候，求你不要丢弃我！我力气衰弱的时候，求你不要离弃我！
>
> 诗篇 71:9

这是诗人年老时的祷告，也是我们为家中老人、为将来的自己献上的祷告。愿主保守每一位读者的身体和心思，也愿我们在弟兄姐妹软弱、忘记的时候，彼此担当，成为主的手和脚。

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 官方网站 国家统计局《2025 年全国人口主要数据》解读（2026-01-19）：2025 年末 60 岁及以上 32,338 万人，65 岁及以上 22,365 万人；民政部、全国老龄办《2025 年度国家老龄事业发展公报》：分别占总人口 23.0% 和 15.9% stats.gov.cn ↗ ↑
2. 学术研究 Jia L, et al. Prevalence, risk factors, and management of dementia and mild cognitive impairment in adults aged 60 years or older in China: a cross-sectional study. Lancet Public Health 2020;5(12):e661-71（2015 年 3 月—2018 年 12 月，全国 12 个省市 96 个调查点，46,011 名 60 岁以上的人；PubMed 33271079） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
3. 学术研究 Wolters FJ, et al. Twenty-seven-year time trends in dementia incidence in Europe and the United States: The Alzheimer Cohorts Consortium. Neurology 2020;95(5):e519-31（欧美 7 个人群队列，49,202 名 65 岁以上的人，1988—2015 年；PubMed 32611641） doi.org ↗ ↑ ↑
4. 学术研究 Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission. Lancet 2024;404(10452):572-628（14 个可以改变的危险因素，合计

约 45%；PubMed 39096926） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

5. 学术研究 Zhou, et al. Population-attributable fractions for modifiable risk factors across the continuum of cognitive decline: Hubei Memory and Aging Cohort Study. J Alzheimers Dis 2025;108(1):367-77（2018—2023 年湖北 8,827 名老人，横断面分析；PubMed 40997210） doi.org ↗ ↑
6. 学术研究 Zhang, et al. Socioeconomic disparities in modifiable risk burden and dementia prevention: A prospective cohort study. J Nutr Health Aging 2026;100909（英国生物银行 344,793 人，随访中位 14.1 年；PubMed 42349092） doi.org ↗ ↑
7. 学术研究 SPRINT MIND Investigators for the SPRINT Research Group; Williamson JD, et al. Effect of Intensive vs Standard Blood Pressure Control on Probable Dementia: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2019;321(6):553-61（美国 9,361 人；美国国立卫生研究院资助；PubMed 30688979） doi.org ↗ ↑
8. 学术研究 He J, et al. Blood pressure reduction and all-cause dementia in people with uncontrolled hypertension: an open-label, blinded-endpoint, cluster-randomized trial. Nat Med 2025;31(6):2054-61（中国农村 326 个村、33,995 名 40 岁以上血压没控制好的人，随访 48 个月；PubMed 40258956） doi.org ↗ ↑
9. 学术研究 Lin FR, et al. Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2023;402(10404):786-97（977 名 70—84 岁听力下降的老人，随访 3 年；美国国立卫生研究院资助；PubMed 37478886） doi.org ↗ ↑
10. 学术研究 Lee CS, et al. Association Between Cataract Extraction and Development of Dementia. JAMA Intern Med 2022;182(2):134-41（美国 ACT 队列 3,038 名白内障或青光眼病人，观察研究；PubMed 34870676） doi.org ↗ ↑
11. 学术研究 Ngandu T, et al. A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial. Lancet 2015;385(9984):2255-63（芬兰 1,260 名 60—77 岁的人；PubMed 25771249） doi.org ↗ ↑
12. 学术研究 Baker LD, et al. Structured vs Self-Guided Multidomain Lifestyle Interventions for Global Cognitive Function: The US POINTER Randomized Clinical Trial. JAMA 2025;334(8):681-91（美国 2,111 名 60—79 岁的人，2 年；美国阿尔茨海默病协会等资助；PubMed 40720610） doi.org ↗ ↑
13. 学术研究 Harrison TM, et al. Brain Imaging Biomarkers and Cognitive Outcomes in a Multidomain Lifestyle Intervention: The POINTER Imaging Ancillary Study. JAMA Neurol 2026;83(6):521-9（983 人做了脑部影像；PubMed 42008251） doi.org ↗ ↑
14. 学术研究 Del Pozo Cruz B, et al. Association of Daily Step Count and Intensity With Incident Dementia in 78 430 Adults Living in the UK. JAMA Neurol 2022;79(10):1059-63（观察研究；PubMed 36066874） doi.org ↗ ↑
15. 学术研究 Sabia S, et al. Association of sleep duration in middle and old age with incidence of dementia. Nat Commun 2021;12(1):2289（英国白厅 II 研究 7,959 人，随访 25 年，观察研究；PubMed 33879784） doi.org ↗ ↑

16. 学术研究 Coe NB, et al. Impact of cognitive training on claims-based diagnosed dementia over 20 years: evidence from the ACTIVE study. Alzheimers Dement (N Y) 2026;12(1):e70197（PubMed 41669119） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 Dickens WT. Reanalyzing the impact of cognitive training over 20 years in the ACTIVE study: Losing the forest in the trees. Alzheimers Dement (N Y) 2026;12(2):e70280（对上一篇的再分析：校正多重比较后，各组的置信区间都包括 1；PubMed 42339399） doi.org ↗ ↑ ↑

18. 学术研究 Coupland CAC, et al. Anticholinergic Drug Exposure and the Risk of Dementia: A Nested Case-Control Study. JAMA Intern Med 2019;179(8):1084-93（英格兰 58,769 名痴呆病人和 225,574 名对照；PubMed 31233095） doi.org ↗ ↑

19. 学术研究 Billioti de Gage S, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer's disease: case-control study. BMJ 2014;349:g5205（加拿大魁北克 1,796 名病人和 7,184 名对照；PubMed 25208536） doi.org ↗ ↑ ↑

20. 学术研究 Gray SL, et al. Benzodiazepine use and risk of incident dementia or cognitive decline: prospective population based study. BMJ 2016;352:i90（美国西雅图 3,434 名 65 岁以上的人，平均随访 7.3 年；PubMed 26837813） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 Eyting M, et al. A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia. Nature 2025;641(8062):438-46（威尔士按出生日期划线的“自然实验”；PubMed 40175543） doi.org ↗ ↑

22. 学术研究 Kivimäki M, et al. Natural experiments of herpes zoster vaccination: Quantifying the implied vaccine effectiveness against dementia. Brain Behav Immun 2026;139:107021（PubMed 42754179） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Cummings JL, Scheltens P. Evoke (+) trials of semaglutide for early alzheimer's disease: Innovations, lessons, and implications. J Prev Alzheimers Dis 2026;13(10):100677（PubMed 42785112） doi.org ↗ ↑

24. 学术研究 Barnes LL, et al. Trial of the MIND Diet for Prevention of Cognitive Decline in Older Persons. N Engl J Med 2023;389(7):602-11（604 名有痴呆家族史、超重的老人，3 年；美国国家老龄研究所资助；PubMed 37466280） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Giem P, Beeson WL, Fraser GE. The incidence of dementia and intake of animal products: preliminary findings from the Adventist Health Study. Neuroepidemiology 1993;12(1):28-36（PubMed 8327020） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 DeKosky ST, et al. Ginkgo biloba for prevention of dementia: a randomized controlled trial. JAMA 2008;300(19):2253-62（美国 3,069 名 75 岁以上的人，中位随访 6.1 年；PubMed 19017911） doi.org ↗ ↑ ↑

27. 学术研究 Wieland LS, et al. Ginkgo biloba for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev 2026;2:CD013661（82 项试验、10,613 人；PubMed 41641880） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Chen Y, et al. Traditional Chinese Medicine for Alzheimer's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Chin Med 2025;53(1):1-15（13 项研究；PubMed 40000385） doi.org ↗ ↑

29. 学术研究 Birks JS, Harvey RJ. Donepezil for dementia due to Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2018;6:CD001190（30 项试验、8,257 人；PubMed 29923184） doi.org ↗ ↑

30. 官方网站 仑卡奈单抗 2024 年 1 月、多奈单抗 2024 年 12 月在中国获批，用于阿尔茨海默病引起的轻度认知障碍和轻度痴呆（每日经济新闻 2024-01-11、界面新闻 2024-12 报道；以国家药监局公告为准） nbd.com.cn ↗ ↑

31. 学术研究 van Dyck CH, et al. Lecanemab in Early Alzheimer's Disease. N Engl J Med 2023;388(1):9-21（1,795 人，18 个月；卫材和渤健资助；PubMed 36449413） doi.org ↗ ↑

32. 学术研究 Sims JR, et al. Donanemab in Early Symptomatic Alzheimer Disease: The TRAILBLAZER-ALZ 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2023;330(6):512-27（1,736 人，76 周；礼来公司开展；PubMed 37459141） doi.org ↗ ↑

33. 官方网站 甘露特钠胶囊（GV-971）2019 年 11 月 2 日获国家药监局有条件批准上市，要求上市后继续研究（中国日报网 2019-11-04 报道） cn.chinadaily.com.cn ↗ ↑

34. 学术研究 Xiao S, et al. A 36-week multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, phase 3 clinical trial of sodium oligomannate for mild-to-moderate Alzheimer's dementia. Alzheimers Res Ther 2021;13(1):62（818 人；作者中有绿谷制药的员工；PubMed 33731209） doi.org ↗ ↑

35. 官方网站 媒体报道：2025 年甘露特钠胶囊注册证到期后停产，同年 8 月再注册申请未获批准；企业称确证性研究仍在进行（虎嗅 2025-08-15 等报道） m.huxiu.com ↗ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录